

A gestão clínica dos pacientes identificados nos registros baseia-se em protocolos estruturados para o manejo de eventos isquêmicos agudos, distúrbios de condução e suporte avançado em terapia intensiva. Para quadros de infarto agudo do miocárdio, a conduta imediata consiste na estabilização hemodinâmica e encaminhamento para cinecoronariografia, com o objetivo de realizar a recanalização do vaso culpado por meio de angioplastia primária e implante de stents farmacológicos. Em casos de doença multiarterial complexa ou reestenoses sucessivas, a estratégia terapêutica migra para a cirurgia de revascularização do miocárdio com o uso de enxertos de artéria mamária e veias safenas.

No contexto das arritmias, a identificação de bloqueios atrioventriculares avançados ou bradicardias sintomáticas impõe a passagem de marcapasso temporário transvenoso como medida de suporte, seguida do implante de marcapasso definitivo. Para pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida e dissincronia ventricular, a linha de tratamento inclui o upgrade para dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca associados a desfibriladores internos. O manejo valvar, especialmente em casos de estenose aórtica severa, envolve a troca valvar por próteses biológicas ou metálicas, dependendo do perfil do paciente.

O suporte farmacológico contínuo é centrado na dupla antiagregação plaquetária, geralmente combinando ácido acetilsalicílico e clopidogrel, além do uso de estatinas em altas doses para estabilização de placas ateroscleróticas. O controle da insuficiência cardíaca e da hipertensão é realizado com inibidores da enzima conversora de angiotensina, betabloqueadores e antagonistas da aldosterona. Em cenários de choque cardiogênico ou séptico, a conduta médica prioriza o suporte ventilatório invasivo, a monitorização hemodinâmica invasiva e o uso racional de drogas vasoativas e antibióticos de amplo espectro, com vigilância constante de funções renais e eletrólitos.